

09 - 05- les schizophrénies - Pr. Adali

Je suis un spécialiste et on va passer au deuxième cours. Donc, le doute de schizophrénie. Alors, c'est un autre portrait de ? Van Gogh.

C'est qui ? C'est qui le monsieur ? Réconnu. Alors, remarque sur le portrait de Van Gogh. Remarque.

Alors, remarque s'il vous plaît. Oui ? Qu'est-ce qu'il est en train de parler ? Un faciès figé, c'est-à-dire que ce n'est pas figé. Est-ce que c'est sans expression particulière ? Est-ce qu'il y a une expression, une émotion sur son visage ? Est-ce qu'il y a une mimique sur son visage ? Ou bien c'est un visage qui est inexpressif ? On est en train d'analyser un tableau.

Qu'est-ce que vous pensez ? Il n'y a pas de réponse juste et réponse fausse. Autre remarque. C'est un autoportrait.

C'est un autoportrait. Je n'ai pas un autoportrait. Si je fais un autoportrait, comment je dois le faire ? Je dois veiller à ce qu'il soit comment ? Bien fait ? Oui.

Valorisant ? Pour moi ? Oui ou non ? C'est-à-dire que je dois paraître belle dans mon autoportrait ? Oui ou non ? Est-ce que c'est le cas pour Van Gogh ? Qu'est-ce qui montre qu'il ne s'est pas mis en valeur dans son autoportrait ? Comment sont ses vêtements ? Donc c'est une tenue qui est négligée. Est-ce qu'il porte une cravate ? À cette époque, les gens portaient des cravates. Est-ce qu'il porte une cravate ? Non.

Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qui témoigne aussi de sa négligence ? Comment est sa barbe ? Qui a parlé de barbe ? Oui, comment est sa barbe ? Pardon ? Pas bien soignée. Ce n'est pas parce qu'il a une barbe, mais qu'il y a une barbe qui n'est pas bien soignée, pas bien coiffée. Comment sont ses cheveux ? Pardon ? Oui, pas bien coiffé.

Quoi encore ? L'arrière-plan, il est comment ? Quand vous regardez l'arrière-plan ? Quand vous le voyez, l'arrière-plan, il renseigne sur quoi, à votre avis ? D'accord. Ce sont des traits qui sont désorganisés ? On ne comprend pas pourquoi il a choisi cet arrière-plan ? D'accord. Quoi encore ? On reviendra à son visage.

Est-ce que c'est une mimique d'un auto-portrait ? Quand vous faites un auto-portrait, quel serait votre mimique ? Quand quelqu'un viendra vous dessiner, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire ? Sourire ou bien au moins avoir une attitude neutre ? Oui ou non ? Van Gogh, il a quel pic ? On peut l'interpréter, moi personnellement, je l'ai interprété de deux façons. Soit que c'est quelqu'un, il a les yeux de quelqu'un qui est en colère, oui ou non ? Sinon, ça peut être aussi un visage qui est dur, froid, oui ou non ? On ne ressent pas une froideur dans son visage ? Pourquoi il y a tout ça dans l'auto-portrait de Van Gogh ? Dont il se perçoit très bien. C'est la façon dont il se perçoit.

Et peut-être que c'est vrai que c'était quelqu'un qui était négligé, qui avait une barbe qui était mal coiffée. C'était ça, son expression du visage. Pourquoi il était comme ça, Van Gogh ? Parce qu'il avait la schizophrénie, parce que c'était un patient schizophrène.

En fait, ce n'était pas un schizophrène seulement, mais c'était un patient qui a un trouble schizo-affectif. Schizophrénie plus un trouble de l'humeur de type bipolaire. Donc il avait les deux, en fait.

C'est ce qu'on appelle le trouble schizo-affectif. Donc Van Gogh était un patient schizophrène. Quand on dit schizophrène, qu'est-ce qui vous vient en tête quand on vous parle de la schizophrénie ? Quels sont les symptômes que vous connaissez de la schizophrénie ? Les hallucinations ? Comment vous le savez ? Vous savez qu'un patient schizophrène a des hallucinations et il a un délire.

Mais comment vous le savez, vous ? Vous êtes en cinquième année, on ne vous a pas encore fait le cours. Comment vous le savez ? Oui, ce sont de bonnes réponses. Oui, un délire, des hallucinations, je suis d'accord avec vous.

Mais comment vous le savez ? Comment vous le savez ? Est-ce parce que vous êtes passé par le service ? Est-ce parce que vous l'avez lu quelque part ? Est-ce parce que vous avez vu des films qui parlent de la schizophrénie ? Quel film vous avez vu ? Il y a un film qui est très connu qui parle d'un patient schizophrène. C'est Beautiful Mind. Je ne sais pas quelle est la traduction en français, mais ça parlait d'un mathématicien qui malheureusement est sombré d'un professeur de maths à l'université et qui a eu la schizophrénie et qui vivait dans son monde imaginaire et délirant.

Il y a aussi un film égyptien qui a essayé de copier la même chose. Ça s'appelle, je ne me rappelle pas, mais je ne sais pas si vous connaissez Ahmed Helmy. Il a fait un très beau film, il l'a copié du film originaire américain, mais il l'a copié à leur façon.

Et on voit vraiment les hallucinations, on voit le délire, on voit la perception de l'environnement du point de vue du patient. Parce que c'est un patient, quand il entrait dans son bureau, je parle du film, nous en tant que spectateur, on voyait qu'il était en train de travailler, c'était un pilote ou un ingénieur, je ne me rappelle pas, à faire des croquis, etc. Donc il travaillait, c'était quelqu'un qui travaillait régulièrement et qui avait des problèmes.

L'histoire du film, c'était quoi ? C'était un jeune homme qui était ingénieur dans une société X, c'était quelqu'un qui travaillait bien, et pourtant il n'a jamais eu de promotion dans son travail. Il disait que son directeur lui en voulait, il l'insultait, ses amis l'entendaient, ses amis se moquaient de lui, d'accord ? Et nous, on croyait, en tant que spectateur, on croyait ce qui a été raconté dans le film. Le metteur en scène avait expliqué ça du point de vue du patient.

Après, quand on a compris, à la fin du film, quand on a compris que c'était un patient qui était

schizophrène, qui était malade, le metteur en scène nous a montré les choses du point de vue de l'entourage, de la famille. Et là, quand ils ont ouvert le bureau, c'était un bureau tout à fait désorganisé, il y avait des papiers partout, c'était quelqu'un qui était, quand il marchait, ses amis avaient pitié de lui, quand il était dans la société, ses amis avaient pitié de lui. Son directeur ne l'a jamais insulté.

Donc, on voit deux réalités, la vraie réalité et la réalité du point de vue du patient. C'est typiquement ce que vous me dites, c'est une pathologie qui est caractérisée par des hallucinations, par un délire, par une désorganisation de la pensée. C'est une pathologie qui est associée au rejet et à l'exclusion du patient.

C'est très difficile pour les familles jusqu'à maintenant d'accepter qu'un de leurs enfants ou qu'un de leurs proches ait cette pathologie-là, parce que c'est synonyme de folie, c'est synonyme d'il n'y a plus rien à faire pour lui, il est devenu fou, il ne pourra pas réussir à l'école, il ne pourra pas réussir à la fac, il ne pourra pas avoir un bon travail. Donc, c'est une destruction totale de l'avenir de la personne. C'est encore perçu de cette façon.

C'est une pathologie qui débute très tôt dans la vie, à l'adolescence. Cependant, il y a aussi des formes à l'âge adulte. C'est la seule pathologie où il y a une égalité des deux sexes.

D'accord. Femme ou homme ? Homme. On avait dit que c'est un sexe ratio qui est de 1. Est-ce qu'on a trois services hommes et un seul service femme ? Pardon ? Non.

Non, je parle de la schizophrénie. C'est une prévalence. Pardon.

C'est un sexe ratio de 1, c'est-à-dire qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui vont être atteintes dans leur vie de schizophrénie. D'accord. C'est le sexe ratio qui est égal à 1. Il y a trois services hommes et un service femme.

Pardon ? Parce que les femmes sont assez bien tolérées par leur famille que les hommes, pour des raisons culturelles, pour des raisons religieuses, pour plusieurs raisons. Donc, elles sont tolérées. Vraiment, on les ramène en hospitalisation que lorsqu'elles sont dans des situations d'extrême agitation, d'extrême agressivité, etc.

D'accord ? Mais gardez en tête que le sexe ratio est égal à 1. Ce sont des patients qui mourront jeunes, disons de moins qu'un patient non schizophrène. C'est-à-dire que si le taux de mortalité dans un pays est de 70 ans, l'âge de mortalité, excusez-moi, de 70 ans, les patients schizophrènes vont vivre 60 ans. Disons de moins que les patients non schizophrènes.

Presque la moitié font des tentatives de suicide et 10% quand même décéderont un jour ou l'autre par suicide. Vous voyez que c'est une population où le taux de mortalité est important. Pourquoi le taux de mortalité est important ? À part le suicide.

Pourquoi ce sont des patients qui mourront jeunes ? Le suicide, c'est juste 10%. Rappelez-vous

quand on a vu en introduction que c'est une pathologie où les patients sont rejetés, sont exclus. Ce sont des patients qui n'ont pas accès aux soins facilement.

Je parle des soins au niveau somatique. Ce sont des patients qui se négligent sur le plan somatique, qui ne prennent pas soin d'eux. Et même s'ils ont des symptômes, ils ne les rapportent pas facilement du fait de la désorganisation de la pensée.

Un patient qui a un infarctus, qui fait un infarctus du myocarde, patient schizophrène, ne viendra pas vous dire « j'ai une douleur ici et qui irradie vers le dos et j'ai dédosé ». Il ne viendra jamais vous le dire. Il va faire son infarctus du myocarde à l'achat et il va décéder à cause de ça. Un patient schizophrène qui a un appendicite ne viendra pas vous dire que « j'ai une douleur localisée au niveau... » Qu'est-ce qu'il va faire ? La douleur se manifeste comment chez un patient qui a une désorganisation de la pensée ? Par de l'agitation.

C'est un patient qui va s'agiter. Il fera sa péritonite, son infection, vous le récupérez dans le service des urgences très tard, alors qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Je donne un exemple simple que j'ai vécu lors de mes gardes pendant le Résidana.

On a reçu une patiente emmenée seule par la police, pas de famille, patiente SDF, schizophrène, SDF et schizophrène, très petite, de taille très maigre, qui portait une gilet bas évasé et il était agité. C'est une patiente qu'on a hospitalisée bien sûr. Quand on a fait l'examen, on a enlevé ses vêtements, on a voulu faire l'examen pour la patiente.

C'est une patiente dont on compte qu'il avait un petit ventre, un tout petit ventre. Donc on s'est dit que peut-être qu'il était enceinte. Le temps de faire une consultation gynéco, parce que ça demandait un rendez-vous, la patiente est entrée en travail le soir.

En fait, c'était une patiente à terme. Puisqu'elle était petite de taille, maigre, on ne croyait pas qu'elle était à terme. La patiente, quand elle est entrée au travail, quand elle avait la douleur, ça s'est manifesté comment ? Par une simple instabilité.

Elle marchait dans les couloirs, elle était très instable, elle ne criait pas, elle ne pleurait pas. Elle était uniquement instable, même pas agitée, instable. Quand est-ce qu'on a su qu'elle est entrée au travail ? Quand elle a rompu la poche des os dans le couloir.

C'est là où on s'est rendu compte que la patiente, elle n'est pas instable, mais elle est entrée au travail. Vous voyez que ce sont des patients qui ne rapportent pas leur souffrance, surtout organique. Ce sont des patients qui décéderont par des problématiques organiques, par des pathologies qui n'étaient pas diagnostiquées à temps parce que les patients ne rapportent pas de symptômes.

Est-ce que c'est clair ? Dans la description clinique, il y a trois syndromes dans la schizophrénie. Dans la schizophrénie, il y a trois syndromes. Le syndrome dissociatif, le syndrome délirant et le

syndrome autistique, qu'on appelle aussi syndrome déficitaire.

Je préfère qu'on parle de syndrome déficitaire pour ne pas faire la confusion avec l'autisme en tant que pathologie. Donc syndrome déficitaire ou autistique, syndrome délirant et syndrome dissociatif. Ces syndromes sont associés à des degrés différents.

Chez certains patients, c'est surtout la dissociation qui prime. Chez d'autres, c'est le syndrome déficitaire. Chez d'autres patients, c'est le syndrome délirant plus le syndrome dissociatif.

En fait, c'est à des intensités différentes de ces trois syndromes-là. Le syndrome dissociatif, la dissociation se définit comme un trouble des fonctions normalement intégrées, identité-mémoire, conscience et la perception de l'environnement. C'est une perte de l'unité psychique, dont le résultat est une incohérence entre pensée et langage.

Juste pour expliquer le syndrome dissociatif, j'espère que quand je donnerai cette explication, vous comprendrez la définition. Vous savez ce qu'on appelle l'unité psychique ? D'autres psychiques, on l'appelle l'unité psychique. Unité, parce que trois sphères de cette unité psychique sont associées à l'unité psychique.

Il y a ce qu'on appelle les émotions, la cognition et le comportement. Les cognissants, c'est quoi ? C'est quoi les cognissants ? Cognition ou la cognition ? Non. Pardon ? Oui, c'est la pensée.

Les émotions ? Bien. Le comportement ? Bien. Chez une personne qui n'a pas de syndrome dissociatif, ces trois sphères-là, ces trois composantes-là vont dans le même sens.

C'est-à-dire, si j'ai une pensée négative de moi-même, une pensée négative de moi-même, je ne vauds rien du tout. Ça va s'exprimer comment en termes d'émotion ? Je ne vauds rien. Je suis nul.

C'est ça la pensée que j'ai en tête. Ça va s'exprimer comment en termes d'émotion ? Par la tristesse, peut-être par la colère. En tout cas, une émotion négative.

En termes de comportement, ça pourrait se traduire comment ? L'isolement ? Les pleurs ? Peut-être autre chose ? Peut-être que je ne vais pas, je ne vauds rien, je ne sais, je suis nul. Peut-être que je ne vais pas, si j'ai, par exemple, je dois postuler pour un travail, je ne vais pas le faire. Donc, c'est un comportement d'évitement.

On va prendre un deuxième exemple. J'ai beaucoup de chance dans ma vie, alhamdulillah. J'ai beaucoup de chance dans ma vie.

Pensée ? Positive. Émotion ? Ça peut être quoi ? La gratitude, je suis contente, heureuse. Comportement ? Je vais affronter plus qu'éviter.

Par exemple, ce poste de travail, je vais aller postuler parce que je sais que j'ai de la chance, je sais que je vauds quelque chose, je sais que j'ai bien travaillé, etc. Donc, les trois sphères, elles

vont dans le même sens. Chez les personnes qui ont un syndrome dissociatif, et notamment dans la schizophrénie, il y a une dissociation ou un éclatement de ces trois sphères.

C'est-à-dire que chaque sphère, elle agit de façon indépendante des deux autres. Par exemple, chez un patient, par exemple, ça c'est un exemple concret et réel que je vous donne maintenant, un patient qui vient de perdre son père ou sa mère, qu'il aimait, il va vous le rapporter et vous le dire en souriant. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? Pardon ? C'est une contradiction entre le fait qu'il a perdu ses parents, entre ce qu'il rapporte comme pensée, parce que la pensée et le langage vont d'eux-mêmes, comme pensée et son émotion.

Il y a la dissociation. C'est que les trois sphères ne vont plus dans le même sens, elles ne sont plus cohérentes, elles se dissocient. Est-ce que c'est clair pour la définition de la dissociation ? Maintenant, chez vous, quand vous allez lire la définition, vous allez comprendre de quoi on parle.

La dissociation se voit dans la pensée. Qui dit pensée, dit langage. Le langage reflète la pensée.

Et dans la vie affective, instinctuelle, comportementale, etc. On va voir en détail. Les troubles du cours de la pensée, dans la schizophrénie, on en a plusieurs, qui témoignent d'une désorganisation de la pensée.

Il y a ce qu'on appelle les troubles de deuxième année. C'est juste une révision de ce qu'on a fait. Un trouble du cours de la pensée, flux de la pensée.

Quels sont les troubles que vous connaissez ? Je vais donner un seul exemple, je vais l'expliquer, mais c'est vous qui allez chercher dans le cours de sémiologie. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Parmi les troubles du cours de la pensée, les plus fréquents en schizophrénie, c'est les barrages.

Le barrage, c'est un arrêt brutal de la pensée. Je vais vous lire une phrase et je vais faire un barrage. La dissociation se définit comme un trouble des fonctions normalement intégrées.

Ça, c'est un barrage. Le patient aimait son idée, il s'arrête, il reprend soit sur la même idée, soit sur une autre idée. C'est ça le barrage.

Fadine, mentale d'influence, c'est à vous de les chercher. Je ne vais pas les expliquer encore une fois. Le contenu de la pensée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans la pensée, c'est des idées parasites, L'automatisme mental, c'est l'impression quand les patients, qu'une force extérieure commande leurs pensées, leurs comportements et leurs actes.

C'est qu'il est sous l'emprise d'une force extérieure et les patients vont vous dire on me fait faire des choses, on me fait dire des choses. Ce n'est pas moi, c'est le moukhabarat, c'est l'attabaqta'ira, c'est... Donc c'est une force extérieure. Il peut vous dire je ne sais pas, c'est une force que je ne connais pas mais elle me fait faire des choses mauvaises.

C'est cette force-là qui m'a poussée à frapper ma mère ou à voler. Donc c'est ça l'automatisme mental. Le souci avec les troubles de la pensée c'est que ce sont des troubles... les patients ne viendront pas vous dire écoutez docteur, moi j'ai un barrage, j'ai une désorganisation de la pensée.

Donc ce sont des troubles qui sont difficilement communicables. Ce n'est pas comme par exemple, ce n'est pas comme les obsessions du toque. C'est pas comme dans le toque le trouble obsessionnel compulsif où les patients ont des idées parasites, ont des obsessions, ils sont conscients de ces idées, ils sont conscients qu'ils sont des idées absurdes et ils le rapportent au médecin.

Les patients schizophrènes ne vont pas vous rapporter la désorganisation de la pensée et les troubles de la pensée qu'ils ont. Donc c'est des troubles au fait qu'on peut déduire grâce au langage. Le langage souvent incompréhensible par les patients et les étudiants qui sont passés par le service peuvent le témoigner.

Les réponses sont hors de propos, sont à côté, ils répondent à côté. Parfois le discours, ça aussi vous l'avez vu, c'est la schizophasie, vous l'avez vu, c'est un discours qui est tout à fait incompréhensible, hermétique. C'est un langage que le patient a inventé, que vous ne pouvez pas pénétrer, que vous ne pouvez pas comprendre.

C'est ce qu'on appelle, c'est vraiment les situations extrêmes chez les patients schizophrènes historiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été traités, ils n'ont jamais vu de médecin. Heureusement qu'on n'en voit plus beaucoup de cas, parce que quand même il y a un accès facile aux soins de santé mentale par rapport à Schellheide. Voilà.

Le souci aussi avec les troubles de la pensée, c'est qu'il contribue à l'isolement du patient, parce qu'un patient qui n'arrive plus à bien communiquer avec son entourage, de toute façon, son discours est incompréhensible, de toute façon, les gens peuvent se moquer de lui, donc ça augmente l'isolement et le rejet du patient. Autre trouble, le jugement de raisonnement, le rationalisme morbide. Je vais donner un exemple d'un étudiant, c'est un des exemples que je donne chaque année aux étudiants de deuxième année.

Ils comprennent très bien le rationalisme morbide. Trouble d'attention, de la concentration, d'accord ? Au niveau de la vie affective, au niveau des émotions, c'est des patients qui ont ce qu'on appelle une ambivalence affective, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire, non, en fait, c'est pas ça, l'ambivalence affective, c'est l'existence de deux sentiments contradictoires en même temps chez un patient, par exemple, vis-à-vis d'une personne. Généralement, les patients, ils sont persécutés par qui ? Pour les étudiants qui sont passés par le service, ils sont persécutés par qui ? Surtout la mère, surtout la maman.

Beaucoup de patients ont une ambivalence affective vis-à-vis de leur maman. Ils vont les

tabasser, ils vont vous dire qu'elle m'a ensorcelée, c'est elle la cause de mes troubles, je vais la tuer. Mais en même temps, ils aiment beaucoup leur maman, quand il lui arrive quelque chose, il va se mettre à pleurer.

C'est ça l'ambivalence affective. Deuxième trouble de la vie affective, c'est ce qu'on appelle la froideur affective. C'est des patients qui ont du mal à exprimer leurs émotions, c'est des patients qui sont, on les appelle inexpressifs, des patients qui sont froids, ils ont un contact froid, pas de mimique, pas d'émotion au niveau du visage, pas d'émotion au niveau du regard, donc c'est des patients qui ont une froideur.

Parfois, la froideur, on va le voir dans les formes de début, pas dans les formes de début, les patients, quand ils sont encore conscients de ce qui leur arrive. J'ai reçu beaucoup de patients, des jeunes, chez qui la pathologie vient de commencer. Ils disaient, parfois ils le disaient spontanément, je commence à être froid.

Quand je me sens comme ça, je me sens froid. C'est-à-dire que je ne ressens plus d'émotion vis-à-vis des gens. Ce n'est pas forcément dans le domaine sentimental, mais des émotions pour leurs amis, des émotions pour leurs parents.

Et parfois, quand on a des doutes diagnostiques, quand on a besoin de plus de symptômes pour poser un diagnostic, surtout dans les formes de début, quand le diagnostic est difficile à faire, poser cette question-là, ce sentiment de froideur, les patients le ressentent très tôt dans le début de la pathologie. D'accord ? Des troubles instinctuels comme les perversions sexuelles, mais ça, c'est des symptômes sexuels. J'estime que vous comprenez la différence entre les deux.

Ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une maladie sexuelle, mais c'est un symptôme sexuel. Comme des masturbations pathologiques, des masturbations devant les parents, des troubles alimentaires ou des symptômes alimentaires comme le piquant, l'anorexie. Donc là, on a terminé la vie affective et instinctuelle.

Maintenant, on va passer au niveau comportemental. L'indécision des gestes, des stéréotypes gestuels, c'est des patients qui répètent le même geste de façon incontrôlable. Il y a ce qu'on appelle les raptus impulsifs.

Les raptus répondent dans l'immédiate suite à un facteur, c'est-à-dire que vous êtes passé à côté de lui, son hallucination lui a dit que tu l'as insulté. Il va vous agresser de façon brutale, c'est-à-dire que ce n'était pas pré-médité. Le raptus, c'est quelque chose de très grave parce que quand vous avez un patient qui a pré-médité son acte, vous pouvez par exemple le voir, vous pouvez s'attendre à ça.

Un patient qui dit qu'il est persécuté par vous, vous pouvez quand même s'attendre à de l'agressivité de sa part. Le raptus impulsif ou le raptus agressif, c'est quelque chose d'imprévisible qui pourrait entraîner des conséquences sur la personne qui a été agressée. On a

des patients qui sont hospitalisés dans le service des médicaux légaux pour des raptus impulsifs qui ont causé le décès des patients, malheureusement.

Des conduites suicidaires, automutilation, fugue, syndrome catatonique, dépersonnalisation, déréalisation, on l'a bien expliqué, syndrome autistique ou le syndrome déficitaire. Maintenant, on a terminé le chapitre du syndrome dissociatif. Maintenant, on est dans le syndrome autistique ou déficitaire.

Déficitaire, autistique, négatif, c'est un syndrome qui est caractérisé par un isolement social et une réduction de l'activité, c'est-à-dire que c'est des patients qui ne vont plus vouloir rencontrer leurs amis, les gens de leur famille, qui vont passer des heures et des heures devant la télé à ne rien faire, des heures et des heures à fumer devant la télé ou bien peut-être que il y aura une réduction de l'activité, même les activités les plus faciles à faire, comme faire sans lit chez certaines patientes qui faisaient le ménage auparavant, même le fait de changer ses vêtements ou de se laver. Vous allez me dire que ces symptômes-là on peut les trouver dans une autre pathologie. Oui, la dépression.

Alors, comment faire la part des choses ? Pardon ? Oui, l'humeur dépressive. C'est juste pour que vous... J'attendais cette réponse que ce syndrome-là, déficitaire, on peut le trouver aussi dans la dépression. D'accord ? On peut le trouver aussi dans les anxiétés très sévères, mais ça c'est le spécialiste, ce n'est pas à votre niveau, mais gardez en tête que pour faire le diagnostic positif de dépression, est-ce que c'est une dépression ? Est-ce que c'est une schizophrénie ? Il faut chercher l'humeur dépressive, il faut chercher les éléments dissociatifs chez le patient.

Schizophrène. Le syndrome délirant. J'ai mis toutes les caractéristiques du syndrome délirant dans le cours de sémiologie.

Un délire, il se caractérise par quoi ? Oui, très bien. Dans la schizophrénie, le délire n'est pas systématisé. D'accord ? Quand on va faire peut-être le prochain cours, des délires chroniques, non dissociatifs, type paranoïa, je vais vous expliquer c'est quoi la systématisation.

Et ça normalement, je l'ai bien expliqué en cours de sémiologie. Le délire dans la schizophrénie, c'est un délire paranoïde, flou, mal systématisé, c'est-à-dire c'est un délire qui n'est pas compréhensible, qui ne suit aucune logique. Est-ce que c'est normal que je sois Dieu, que je sois le prophète ? Non.

Donc c'est un délire qui est non systématisé, avec thématiques multiples, mystiques, de mégalomanie aussi, des mécanismes multiples, surtout hallucinatoires. Les hallucinations sont très caractéristiques de la schizophrénie. La participation émotionnelle, Schneier, le vécu émotionnel.

Le vécu émotionnel, c'est-à-dire comment moi, je vis mon délire. Je suis la plus belle femme du monde. C'est quel type de délire ? Mégalomaniaque.

Alors, comment je devrais normalement le vivre émotionnellement ? Avec joie. Donc la participation émotionnelle, c'est la joie, c'est l'euphorie. Il y a des gens qui veulent me tuer.

C'est quelle thématique délirante ? Persécution. Comment normalement je devrais vivre ces thématiques délirantes ? La participation émotionnelle, elle est de quel type ? L'angoisse, la peur. Pourquoi c'est important d'analyser la thématique délirante, la participation émotionnelle ? Parce qu'en fonction de la participation émotionnelle, il pourra ou pas un risque de passage à l'acte.

Si je vous dis que les gens veulent me tuer, ou là une personne X veut me tuer avec un persécuteur désigné, mais quand même je dis, mais écoute, je vais aller voir la police ou bien Premier exemple. Deuxième exemple, la personne X veut me tuer, mais j'ai très peur et je vais aller, je vais me défendre. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Le passage à l'acte.

Quand la participation émotionnelle, elle est faible, c'est-à-dire que je ne suis pas très angoissé, très en colère, le risque de passage à l'acte, il est faible. Passage à l'acte hétéro-agressif, le fait que j'aille agresser ou la tuer cette personne-là qui veut me tuer. Mais quand la participation émotionnelle, elle est forte, à type d'angoisse, de peur, de colère, de tristesse, le risque de passage à l'acte, il est important.

Donc c'est important aussi d'analyser la participation émotionnelle. Beaucoup de troubles peuvent être associés à la schizophrénie, troubles du sommeil, l'agressivité, la violence, l'abus de substances, l'anxiété, la dépression. Il y a aussi une classification de symptômes positifs ou qu'on appelle aussi symptômes productifs.

C'est tout ce qui est délire, hallucination, désorganisation, syndrome dissociatif. Par opposition aux symptômes négatifs, c'est tout ce qui est syndrome autistique ou déficitaire, retrait social, isolement, etc. Dans le DSM, beaucoup de types de schizophrénie.

Il faut savoir que cette classification de schizophrénie, dans le DSM, on ne parle pas d'une schizophrénie, mais on parle d'une schizophrénie parce qu'il y a plusieurs types. Ces types-là, c'est en fonction de quoi ? De la prédominance de l'un ou de l'autre des trois syndromes qu'on a vus, la dissociation, le délire et le syndrome déficitaire. Par exemple, je donnerais un exemple le plus parlant de schizophrénie désorganisée.

Dans la schizophrénie désorganisée, qu'est-ce que vous allez trouver ? Une désorganisation, la désorganisation, la dissociation. Schizophrénie paranoïde, c'est comme le délire paranoïaque. Donc, on va trouver le délire et l'hallucination.

Les formes de débuts. Les formes de débuts les plus classiques, c'est les formes de débuts progressifs, plus de 6 mois. Il y a plusieurs phases.

Il y a ce qu'on appelle la phase saine, où il n'y a rien. La phase prodromique, où il y a des symptômes, des prodromes, qu'on appelle des prodromes. Est-ce que vous avez des prodromes

? Parce que ce sont des symptômes qui ne sont pas spécifiques, qui vont apparaître.

On ne pourra jamais poser un diagnostic à partir de prodromes. Les prodromes se font, on va analyser de façon correcte, les prodromes de façon rétrospective. C'est-à-dire, quand on va passer à la phase active, la phase de déclaration de la maladie, qu'on va se dire, tiens, ce patient-là, il nous a rapporté que, quand il avait 20 ans, quand il avait 17 ans, il avait commencé à se douter de l'existence de Dieu, par exemple, à avoir des idées philosophiques, à plus s'intéresser à la philosophie, par exemple.

Donc, les prodromes, en tant que symptômes seuls, ne permettent pas de poser un diagnostic. D'accord ? La phase active, c'est la phase, voyez, Heda, c'est pousser rémission, pousser rémission. Et la phase résiduelle ou stable, c'est la phase, généralement, quand les patients font très peu de poussées, d'accord, mais qui gardent quand même des symptômes résiduels, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas guérir.

Rappelez-vous, regardez bien, pardon, le graphique, on n'arrive jamais à la situation zéro, plutôt à la phase saine, on n'arrive jamais à la phase saine, il y aura toujours des symptômes, la phase résiduelle, c'est-à-dire que c'est une maladie qui ne guérit pas, mais qui se stabilise. Est-ce que c'est clair ? Maintenant, on va voir les prodromes, on les a expliqués, c'est des signes vagues, difficiles à détecter, retrait social, négligence de l'hygiène, manque de motivation aux études, surtout aux études, des troubles de l'intention, de la mémoire, des fonctions exécutives, des troubles du sommeil, des croyances bizarres, comme j'ai dit, j'avais un étudiant au bac, dans le début, dans les prodromes de la maladie, c'était un intérêt croissant à tout ce qui est livre de philosophie, son oncle était un enseignant de philosophie, il prenait tous les livres de son oncle et les lisait, il ne comprenait rien du tout, mais il faisait sortir des théories philosophiques bizarroïdes, un peu bizarres, d'autres patients avaient commencé à se douter de l'existence de Dieu, l'existence des prophètes, à se douter que leurs parents sont leurs vrais parents, c'était juste des doutes, ce n'était pas des délires. Tous ces symptômes-là, on les voit dans quelles situations ? Des changements brusques d'intérêt un jeune qui aimait bien faire du sport par exemple, et du jour au lendemain, il demande à ses parents de l'inscrire en cours de musique, brusquement, brutalement, pourquoi tu veux faire ce changement aussi radical ? C'est comme ça, il ne donne pas d'explication.

On peut les voir dans quelles situations ? L'adolescence, c'est typiquement tout ce qu'on vient de voir, c'est typiquement l'adolescence, c'est des jeunes qui se remettent en question, qui remettent en question leurs croyances, qui peuvent changer brusquement d'intérêt, ils peuvent ne plus être motivés à aller à l'école, à avoir des troubles de l'attention, c'est ça le grand problème, le grand souci avec la phase prodromique, c'est qu'elle n'est pas spécifique, le concept, comme j'ai dit, est rétrospectif, il n'y a pas de traitement reconnu, on ne peut pas traiter, et le souci, pourquoi on avait parlé du traitement reconnu, parce que les études ont montré que plus vous traitez précocement, quand je dis précocement, la phase prodromique, vous devez faire le diagnostic idéalement dans la phase prodromique, plus vous traitez précocement, mieux le pronostic, et

parce que le traitement permet de préserver les capacités, surtout cognitives du patient, parce que qu'est-ce qui se passe dans la schizophrénie et même dans les troubles bipolaires ? Chaque poussée aggrave le pronostic cognitif et laisse des séquelles cérébrales qui sont irréversibles. Donc si vous prenez 10 ans pour introduire un traitement que votre patient fait une poussée chaque année ou chaque deux ans, ses capacités cognitives vont se détériorer et ça va être de façon irréversible. Donc le fonctionnement du patient va être altéré, donc c'est un patient chez qui vous ne pouvez plus faire une insertion socioprofessionnelle et une remédiation cognitive correcte.

Il y a d'autres types de débuts, c'est les formes à début brutal, moins de 6 mois, qui peuvent mimer un accès psychotique aigu. C'est l'évolution, j'ai bien dit moins de 6 mois, mais c'est l'évolution qui va dire que ce patient-là va virer ou pas vers la schizophrénie. Début brutal comme un accès psychotique aigu, une manie atypique, c'est-à-dire un accès maniaque avec des éléments par exemple dissociatifs qui n'existent pas normalement dans la manie, dans l'accès maniaque.

Une dépression atypique, une humeur dépressive mais avec une désorganisation de la pensée, c'est bizarre. Donc, c'est des formes à début brutal atypiques. L'éthiopathogénie, comme toutes les pathologies psychiatriques, est multifactorielle.

La génétique joue un rôle important dans la schizophrénie. L'hypothèse neurobiologique de désordre au niveau du système mésocortico-limbique. Les hypothèses neurodéveloppementales, surtout en période périnatale.

Les facteurs de stress psychosociaux, l'interaction gène-environnement pour conclure que c'est un modèle complexe, polygénique, il n'y a pas un seul gène, et multifactoriel. On rajoute à ça la notion de vulnérabilité, parce que vous pouvez avoir des patients qui sont vulnérables, qui ont tous les facteurs de vulnérabilité, génétiques par exemple, pour développer une schizophrénie, et quand l'entourage, quand l'environnement est soutenant, ce patient peut ne pas développer sa maladie. Vous pouvez avoir un patient qui n'a pas de facteur de vulnérabilité génétique par exemple, mais qui est placé dans un environnement délétère, des parents violents qui vivent dans la rue, des décès parentaux précoces, donc c'est un environnement délétère qui pourrait entraîner ou précipiter l'apparition de la schizophrénie.

L'évolution, comme je l'ai dit, c'est une pathologie poussée-rémission, des périodes de poussées, de perturbations, où les symptômes sont nombreux, intenses, des périodes où les symptômes sont soit absents, mais à 100% absents, ça n'existe pas. C'est plutôt des symptômes qui sont présents, mais qui sont mineurs. Les phases, on les a vues, les quatre phases.

Les complications, c'est la rechute, et j'ai bien dit que les rechutes, c'est toxique pour le cerveau. Les rechutes sont provoquées par l'arrêt du traitement. Typiquement, dans la schizophrénie, il n'y a pas de bonnes observances.

Le premier challenge dans la schizophrénie, c'est de permettre aux patients ces observances thérapeutiques. Les patients arrêtent leur traitement. C'est le premier défi des psychiatres, c'est d'assurer l'observance thérapeutique.

Parce que quand il n'y a pas d'observance, il y a la rechute. Quand il y a la rechute, il y a l'aggravation de la symptomatologie, et ça a des répercussions au niveau socio-professionnel. Dans la schizophrénie, je ne sais pas si je l'ai mis quelque part ici... Dans la schizophrénie, il y a une absence totale de ce qu'on appelle l'insight, ou la conscience du trouble.

Ce n'est pas comme le patient dépressif qui sait qu'il est malade et qu'il a besoin de traitement. Le patient schizophrène n'est pas malade, il est normal. Rappelez-vous du film que je vous ai dit, que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est la perception du patient de son environnement, de son point de vue.

Pour lui, tout est normal. Il est dans son bureau, il est en train de travailler, alors que quand on voit du point de vue de l'entourage, c'est des bouts de papier partout, c'est un bureau qui est tout à fait désorganisé, etc. J'ai reçu beaucoup de patients.

Parfois, j'ai reçu des patients qui ramassaient des ordures. Quand on a demandé lors de la garde d'être amené par la police, on a demandé « qu'est-ce que vous portez ? » Si vous ne connaissez pas la pathologie, qu'est-ce que vous allez vous dire ? Il est en train de se moquer de moi. Pour lui, il était convaincu que c'était des choses qu'il pouvait revendre, alors que c'était des cartons de lait, c'était des bouts de journaux, des morceaux de papier.

Il les a ramassés de la poubelle. Mais pour lui, c'est quelque chose qu'il peut revendre. Donc, c'est une absence totale d'insight.

Pour lui, il n'est pas malade. Pourquoi il va prendre son traitement ? Il n'est pas malade. Parfois, les patients peuvent même délirer sur le traitement.

Ils vont vous dire « vous m'avez intoxiqué avec le traitement. » C'est pour ça qu'ils arrêteront leur traitement. Et le suicide, on en a parlé.

Les pronostics, il y a beaucoup de facteurs de bons pronostics. La forme paranoïde quand il y a le délire, la forme schizoaffective quand il y a des symptômes timides, le début tardif, moins de 35 ans, début de façon aiguë, une peau en adaptation prémorbide, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était bien inséré professionnellement, bien inséré socialement, et qui a développé la maladie. Il a de bons pronostics par rapport à quelqu'un qui n'a pas pu terminer ses études, qui n'avait pas de travail, avant la déclaration de la maladie prémorbide, avant que la maladie soit diagnostiquée.

La bonne réponse au neuroleptique, c'est-à-dire que vous introduisez le traitement, les symptômes s'améliorent. Il y a beaucoup de patients qui ont une mauvaise réponse au

neuroleptique, c'est-à-dire que l'amélioration des symptômes est partielle. On peut aller d'une amélioration partielle à une totale résistance au traitement.

La bonne réponse au neuroleptique est un facteur de bons pronostics. L'existence de coopération avec le patient et son entourage. Diagnostics différentiels, vous pouvez les déduire vous-même, l'accès psychotique aigu, le trouble chronique non dissociatif et bipolaire.

Pour ces diagnostics différentiels-là, on va les voir dans leurs cours respectifs. C'est-à-dire que comment faire le diagnostic différentiel avec l'accès psychotique aigu et le délire chronique non dissociatif, on va le faire dans les cours accès psychotique et délire. Ne vous alarmez pas.

Prise en charge, quel est le but du traitement? Bien sûr, traiter, réduire les symptômes, aider les patients à prendre conscience de la maladie, mais surtout préserver les capacités cognitives du patient, parce que c'est ce qui cause la problématique réelle du patient schizophrène. Vous voyez qu'en rentrant à cet amphi, pour vous, le problème réel des patients schizophrènes, c'est l'agressivité et l'agitation, oui ou non? Ou le délire. Alors que le problème le plus difficile à résoudre, c'est les problèmes cognitifs chez ces patients.

Vous savez que l'agitation et le délire, c'est le symptôme le plus facile à traiter pour les psychiatres, je parle des psychiatres. Le souci dans la schizophrénie, c'est la réhabilitation, c'est comment rendre ce patient-là fonctionnel par rapport à ce qu'il a été avant le diagnostic de la maladie et comment préserver ses capacités cognitives, prévenir les rechutes et le soutien de l'entourage. Voilà, j'ai parlé de l'EatSight, les défis dont la prise en charge, c'est l'absence d'EatSight, l'abus de substances, c'est un facteur aggravant comme vous l'avez bien dit, c'est un facteur aggravant le pronostic de la maladie parce que ça entraîne beaucoup de symptômes, une richesse importante des symptômes et ça accentue les rechutes.

Le dernier point, c'est pour expliquer qu'à part le fait que les rechutes sont toxiques pour le cerveau, un patient qui faisait une rechute et qui récupérait de sa rechute après, je dirais, trois mois, c'est-à-dire qu'il se stabilisait après un mois, deux mois, quand il va faire beaucoup de rechutes à la langue, il va récupérer plus longtemps, c'est-à-dire qu'il va se stabiliser en six mois, en huit mois, en un an, peut-être ne pas se stabiliser guère. La fréquence aussi des rechutes, elle entraîne une récupération très lente, une stabilisation lente des patients. Vous avez fait le cours des neuroleptiques ? Non, pas encore ? Le traitement médicamenteux repose essentiellement la pierre angulaire du traitement médical de la schizophrénie, c'est les neuroleptiques et surtout les neuroleptiques atypiques, parce qu'ils ont moins d'effets secondaires.

Vous allez faire ça dans le cours des neuroleptiques. Il y a deux types de neuroleptiques, il y a les neuroleptiques classiques et les neuroleptiques atypiques. Les neuroleptiques atypiques sont le traitement de première intention, parce qu'ils traitent bien les maladies, ils traitent bien les symptômes, mais qu'ils n'ont pas beaucoup d'effets secondaires.

Ce qu'on craint avec les neuroleptiques classiques, c'est les effets secondaires extra-pyramido, parce que ça peut donner un syndrome extra-pyramidal, tremblement, un syndrome typiquement neurologique, qui peut être très gênant pour le patient. Les autres traitements qu'on donne, c'est des traitements symptomatiques. Il y a le traitement de fond, c'est les neuroleptiques, mais des traitements symptomatiques en fonction des symptômes qui sont associés.

Si le patient est très angoissé, on peut donner des anxiolytiques. S'il fait une dépression, parce qu'un patient schizophrène, il a le droit aussi de déprimer, on va lui donner un antidépresseur. Si c'est un trouble schizoaffectif, on va donner un timorégulateur.

Donc ça, c'est des traitements adjuvants associés. Le traitement de fond, c'est les neuroleptiques. Les TCC, jamais de TCC quand vous avez un patient en rechute instable, il faudrait que le patient soit stable au niveau cognitif, au niveau de sa maladie.

On vise dans les TCC à apprendre au patient de nouvelles compétences sociales et relationnelles. Rappelez-vous, c'est un patient qui n'arrive plus à se prendre en charge lui-même. Il ne peut pas faire son lit, il ne peut pas préparer son repas, il ne peut pas se laver.

On vise à aider le patient à développer de nouvelles compétences sociales et relationnelles, à parler librement de ses croyances par rapport à la maladie, par rapport aux symptômes qu'il a, soit en individuel ou soit en groupe. Identifier ses pensées négatives, faire de la remédiation cognitive. La remédiation cognitive est un type de traitement, de psychothérapie qui vise à remettre, mettre à niveau les capacités cognitives du patient.

C'est-à-dire capacité de concentration, d'attention, les capacités organisationnelles, comment organiser une tâche. Là encore, il faudrait que le patient soit traité préconçument pour préserver ses capacités cognitives. Et les thérapies psychos, comme son nom l'indique, éducatives.

Je crois qu'on avait fait de la psychoéducation dans les techniques de communication, si vous vous rappelez bien. C'est un type d'approche qui vise à enseigner au patient et à sa famille les symptômes de la maladie, l'intérêt du traitement, comment repérer préconçument une rechute, comment savoir que le patient a rechuté, comment gérer une rechute, comment gérer une agitation à la maison. C'est des situations cliniques particulières qu'on éduque la famille et le patient par rapport à ces situations-là.

Les programmes de réhabilitation. Généralement, les programmes de réhabilitation nécessitent l'intervention de l'État. D'accord ? Plusieurs programmes comme Allocation adulte handicapé, ça pourrait, ça permettrait, c'est une allocation qui permettrait parce que les patients schizophrènes sont considérés comme des patients qui ont un handicap psychique.

Donc ils ont droit à cette allocation adulte handicapé qui va leur permettre de rester dans le système des soins, d'avoir une couverture sociale, d'avoir beaucoup de facilité dans leur vie, les

recevoir peut-être en hôpital de jour pour des séances psychothérapeutiques, leur assurer une formation professionnelle qui est adaptée à leur capacité cognitive actuelle, à un reclassement professionnel. On reçoit beaucoup de patients, par exemple, qui étaient des enseignants collège ou primaire et qui n'ont plus cette capacité cognitive d'enseigner aux étudiants. Donc on fait un réaménagement du poste de travail, un reclassement professionnel, par rapport à ça, il peut prendre un poste plus administratif.

D'accord ? Et il y a aussi la conception d'environnement protégé, adapté, comme les appartements thérapeutiques. C'est des appartements qui sont conçus pour héberger des patients qui sont schizophrènes, c'est pas pour vivre pour la vie, mais pour les entraîner à comment vivre seul ou comment vivre avec leur propre famille. C'est un environnement sécurisé, ils reçoivent de la visite de la part, ça n'existe pas en Maroc malheureusement, de la part d'une assistante sociale, d'une infirmière en psychiatrie, d'un psychiatre, ils sont accompagnés dans leurs tâches quotidiennes.

L'ECT, vous avez fait le cours de l'ECT, le cours de l'ECT, sismothérapie, électroconvulsivothérapie, c'est un traitement par simulation magnétique transcraniale, ce sont deux thérapeutiques, l'électroconvulsivothérapie c'est le traitement par électrochoc. C'est le premier traitement qui a été peut-être indiqué pour toutes les pathologies psychiatriques même dans les années 1900 chez Hainjan. C'est un traitement qui a regagné un intérêt récemment dans les formes surtout résistantes au traitement.

C'est un traitement qui est très qui donne de très bons résultats chez les patients résistants au traitement. Il y a des indications particulières à l'ECT. L'hospitalisation, quand il y a une urgence, patients empoussés, patients agités qui présentent un risque pour lui ou pour les autres, mais aussi dans les formes de début pour pouvoir observer le patient et faire un diagnostic de la maladie.

En tant que médecin généraliste, pourquoi on vous enseigne ça ? Quel est votre rôle ? Vous avez un rôle important parce que vous êtes une personne de confiance pour le patient et sa famille. Vous êtes le médecin généraliste du quartier. Vous pouvez avoir un rôle important dans le dépistage précoce des troubles psychotiques.

Le suivi somatique quand vous recevez vos patients au schizophrène parce que vous êtes des étudiants brillants et qu'on vous a enseigné à l'amphithéâtre que les patients au schizophrène ne rapportent pas leurs symptômes somatiques facilement. Qu'est-ce que vous allez faire en consultation quand vous recevrez un patient au schizophrène pour un symptôme organique ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Pardon ? Oui, mener l'examen général. C'est que vous allez pousser l'examen.

Si pour un patient non schizophrène vous allez demander le bilan A, B, C, D, pour ce patient au schizophrène, vous allez demander, faire l'examen général et demander le bilan A, B, C, D, E, F,

G, H. Vous allez être plus socieux de son état de santé parce que vous savez que le patient ne va pas vous rapporter tous les symptômes dont vous avez besoin. Évaluer la compliance parce que vous recevez votre patient pour une pathologie organique et vous savez très bien que ce patient-là est schizophrène. Vous lui dites « By the way, qu'en est-il de votre traitement neuroleptique ? Est-ce que vous le prenez ? Quand est-ce que vous avez vu votre psychiatre pour la dernière fois ? » Ça fait deux ans.

Là, parce que vous êtes une personne de confiance pour le malade, vous dites aussi à la famille qu'il faudrait qu'il aille voir son psychiatre, il est en arrêt depuis deux ans, donc il risque de rechuter, etc. Donc vous voyez que ce sont des gestes simples qui peuvent rendre service énormément aux patients et à sa famille. Reconnaître précocement les signes d'une rechute.

Vous recevez un patient schizophrène qui accompagne sa maman pour une prise de tension artérielle. Vous voyez que le patient est instable. Puisque vous le connaissez, c'est le patient du quartier, vous le connaissez, vous voyez qu'il est instable.

Vous dites à la maman « Écoutez, votre fils, je crois qu'il commence sa rechute. Il est en rechute. » Peut-être que c'est un symptôme que la maman n'a pas détecté.

Je vous remercie.